

Brain & Mind

Morning Conference Case

병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성
곽용태 / 효자병원

1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

물건을 자주 쌓아두는 73세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

병적인 웃음과 울음으로 내원한 79세 여성

증례

79세 여성이 최근 6개월 사이에 발생한 대소변 실수, 부적절한 상황에서 급격하게 시작되고 통제되지 않는 울음과 웃음이 주기적으로 나타나는 증상으로 내원하였다. 환자는 고졸 학력에 오른손 잡이 가정 주부였으며, 10년 전부터 고혈압과 당뇨병 진단을 받고 약물 치료를 하고 있다. 가족력에서 특이한 소견은 없었다. 환자는 1년 전부터 가끔 물건을 잊어버리고 찾지 못하는 증상 등이 있었지만 집안 생활에 지장이 있을 정도는 아니었고 이와 연관된 진료나 치료는 하지 않았다.

환자는 6개월 전 갑작스럽게 혈압이 상승하고 말이 약간 어눌하다는 느낌을 받았으나 심하지 않아 동네 병원에서 혈압 약을 조절하고 어눌한 증상은 호전되었다고 한다. 그러나 이후 간헐적으로 대소변을 실수하는 증상이 생겼으며, 점차 감정 상태가 불안정해지며, 갑자기 울거나 웃는 일이 많아졌고, 그 정도나 지속 시간이 심해져 신경과로 입원하였다.

입원 당시 환자는 전반적으로 말이나 행동이 느리고, '말이 잘 안 나온다', '불안하다', '소변 조절이 안 된다' 등의 불편을 호소하였다. 문진 중에도 이유 없이 웃기도 하였고, 조절이 되지 않아서 문진의 진행이 쉽지 않았다. 신체 검사에서는 고혈압과 양

측 하지의 경도 부종 이외에 특이 소견은 없었다. 신경학적 검사 상 의식은 비교적 명료하였으나 경도의 기억력 저하와 심진 반사의 전반적인 항진과 양측 손바닥턱끝 반사, 미간반사 등이 관찰되었고, 보행 시 느리고 넓은 보폭으로 불안정한 걸음을 보였다. 입원 후 시행한 mini-mental state examination(MMSE) 검사는 24, 임상치매

척도(clinical dementia rating, CDR)는 0.5였다. 뇌영상 MRI 검사에서는 T2 강조영상에서 뇌실 주변에 전반적이고 심한 백질 변화가 보였다(그림 1). 혈액 검사에서 특이한 소견은 없었다. 임상적 소견과 검사를 종합하여 혈관성치매의 일종인 Binswanger encephalopathy로 진단하였다.

환자는 입원 후 사소한 일에도 이유 없

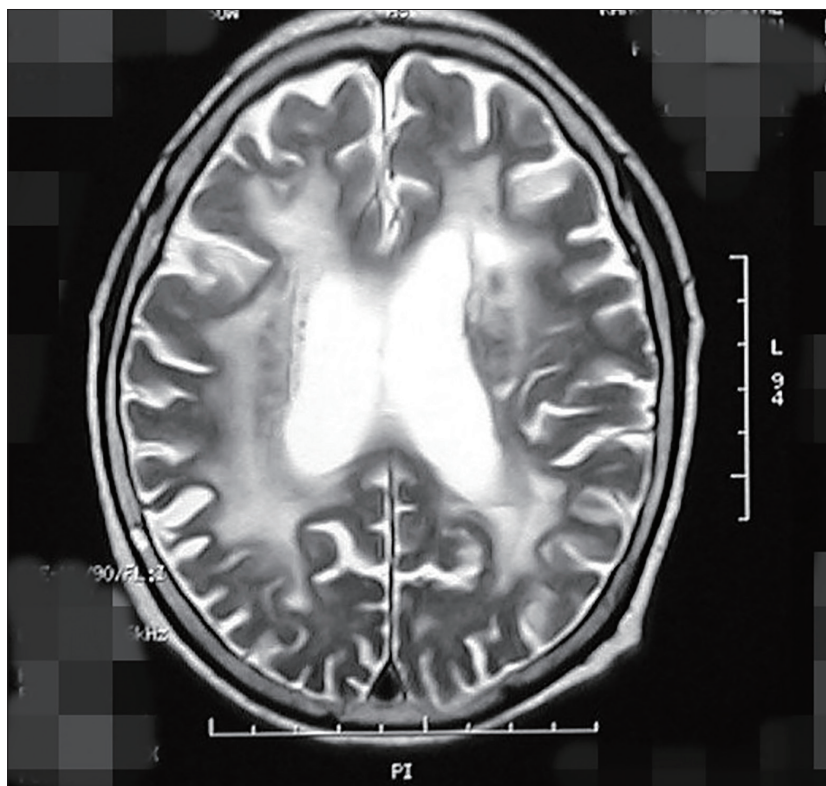


그림 1. T2 강조 MRI 영상에서 전반적인 백질의 변화가 관찰된다.

이 울기도 하다가 갑자기 주체할 수 없는 웃음을 터트리는 등의 증상이 반복되었다. 이러한 증상이 어느 정도 사라지면 본인의 행동에 대해서 당황하기도 하고 불안이나 공격성을 보이기도 하였다. 불안과 공격성으로 리스페리돈 1 mg과 아티반 1 mg을 사용하고 이후 불안과 공격성은 감소하였으나 주체할 수 없이 울거나 웃는 등의 증상은 여전히 있었다. 정서적 불안정성 치료를 위하여 에스시탈로프람 5 mg을 추가하였다. 에스시탈로프람 추가 후에도 증상 변화가 없어 일주일 후 용량을 10 mg까지 증량하였고, 이때부터 서서히 울거나 웃는 증상의 빈도나 시간이 줄어들기 시작하였다. 또한 이 증상을 유발할 수 있는 스트레스나 상황 등에 대한 인지 및 처리를 위하여 인지행동 치료를 병용하였다. 환자는 입원 10일 후부터 부적절한 울음과 웃음이 서서히 감소하였고, 그 정도도 점차 줄어들어 입원 20일부터는 증상이 거의 없어져 퇴원하여 외래에서 치료 중이다.

고찰

최근 노인 인구가 증가함에 따라 아무런 증상이 없거나, 경미한 신경학적 증상과 같이 감정 조절장애로 병원을 찾는 노인 환자가 늘고 있다. 보통 감정 조절장애가 있으면 정신과를 먼저 찾는 경우가 많지만, 본 증례처럼 고령이며 경미할지라도 신경학적 손상과 같이 이 증상이 나타난다면 이 증상이 뇌 병변에 의한 신경학적 증상의 일환일 가능성이 높다. 본 환자의 경우는 뇌 MRI 검사와 임상증상을 고려할 때 정서적 불안정성은 다발성 뇌경색에 의한 신경학적 증상으로 볼 수가 있다.

감정 조절장애는 뚜렷한 기질적 질환

없이도 나타나기도 하지만 다양한 질환과 동반되어 나타나기도 한다. 그런데 감정은 매우 포괄적인 개념이어서 의료에서는 감정이라는 용어보다는 어떤 때는 정서(affect) 또 어떤 때는 기분(mood)이라는 표현을 사용한다. 이 두 개념은 미묘하게 다른데, 정서는 객관적으로 관찰할 수 있는 모습을 말하는 반면, 기분은 대상자의 주관적인 느낌이다. 즉, 치료진과 같은 외부인이 보기에 대상자가 침울한 표정이면 정서 상태는 침울한 것이고, 치료진과 같은 외부인이 보기에 침울해 보일지라도 대상자 본인이 “즐거워요”라고 말한다면 기분 상태는 즐거운 것이다. 정서는 대상자가 하는 말과는 상관없이 제3자에 의한 표정, 행동 등의 비언어적인 요소가 평가 대상이다. 즉, 객관적인 지표가 된다. 반면, 기분은 대상자가 외부에 비치는 모습과는 상관없이 없다. 다만 그가 주관적으로 언어적으로 표현하는 요소가 평가 대상이다.

대부분 젊은 나이에 발병하는 감정장애는 이 두 요소가 잘 일치한다. 그런데 이 두 가지가 극단적으로 차이가 나고 이것이 신경학적 병변 때문에 나타날 때 이 증상을 감정실조증(pseudobulbar affect, PBA)이라고 한다. 주로 환자 자신의 기분과 관계없이 부적절하게 갑자기 조절되지 않고 울기도 하고 웃음을 터트리는 증상으로 나타난다.

과거에는 이를 정서적 불안정(emotional lability), 병적 웃음과 울음(pathological laughing and crying), 발작 웃음과 울음(compulsive laughing or weeping), 감정 실금(emotional incontinence) 등으로 불리웠으나 최근에는 신경학적 원인으로 인한 감정 조절 어려움을 강조하기 위해 PBA

라는 용어를 더 많이 사용하고 있다. PBA는 환자나 환자 가족 등에게 당혹감, 불안 등을 야기하는 등 심각한 영향을 줄 수 있고, 사회적으로 위축되거나 고립될 수 있는 중요한 행동장애이다. 또한 임상적으로는 이 증상이 나타난다면 순수한 정신질환이 아닌 다양한 신경계 질환에 의한 증상일 가능성이 있으므로 기저질환을 확인해야 한다. 기저질환이 있는 경우 이 증상과 더불어 기저질환의 증상과 함께 나타난다(예를 들어, ALS 경우 마비, 뇌졸중 경우 요실금 등). 근위축성측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) 환자의 50%, 외상성 뇌 손상(trumatic brain injury) 환자의 48%, 다발경화증(multiple sclerosis, MS) 환자의 46%, 처음 뇌졸중이 생긴 환자에서 28~52%에서 이 증상이 나타난다. 병적 웃음과 울음은 1) 갑자기 본인의 의사와 관련 없이 예측할 수 없이 나타나며, 2) 유발 원인이 없거나 있어도 그 원인에 비하여 과도하게 나타나고, 3) 불수의적인 분노 폭발이나 좌절이 같이 나타나는 특징을 보인다.

아직까지도 PBA와 연관된 정확한 해부학적 위치는 알려져 있지 않지만, 피질-교뇌-소뇌 회로(cortico-ponto-cerebellar pathway)와 연관되어 있다고 한다. 이 회로 내에 위치한 해부학적 부위의 손상뿐 아니라 세로토닌, 노르에피네프린, 도파민, 글루타메이트, 아세틸콜린 등의 신경 전달 물질의 이상도 연관되어 있다고 한다. 과거에는 소뇌가 단순히 운동 기능 조절만 한다고 알려져 있었는데, 최근에는 소뇌가 운동 기능의 모니터링뿐 아니라 감정 반응을 모니터링한다고 알려져 있다. 그래서 이 부위의 신경회로가 손상이 되면 감정 반응을 모니터링하거나 제어하는 것이 문제가 생

기게 되고 이것이 부적절한 정서를 유발한다고 한다.

현재까지 이 증상에 대한 약물 치료는 2가지가 알려져 있다. 첫 번째는 선택적 세로토닌 재흡수 차단제(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)이다.¹

주로 fluoxetine, sertraline, paroxetine, citalopram과 같은 약물이 연구되었으며, 어느 정도 유용하다고 보고되었다. 이 외에도 삼환계 항우울제도 효과가 있다고 알려져 있으나 부작용 때문에 2차적인 치료로서 권유되고 있다. 하지만 이 약들은 이 증상에 정식 치료제로서 FDA 승인을 받지 않았다. 두 번째로는 기침 억제제로 많이 사용되는 글루타메이트 대항제인 dextromethorphan과 말라리아 치료제인 quinidine 복합 제제가 이 증상 치료제로

유일하게 FDA 승인을 받았다.² 이 약은 기존의 도파민이나 세로토닌과 직접적으로 관련이 없어 PBA 기전이나 치료에 새로운 방향을 제시하였다고 할 수 있다. 다만 이 약제는 각각의 성분은 새로이 개발된 약제도 아니고 고가가 아님에도 불구하고 새로이 증상에 승인받은 복합제는 고가의 희귀 신약으로 등록되어 있어 우리나라에서는 구입도 사용도 쉽지 않아 일상적으로 임상에서 사용할 수는 없다.

본 환자의 경우에는 다발성 뇌졸중이 있었음에도 불구하고 그 증상이 뚜렷하지 않고 미묘한 신경학적 증상만 있는 상태에서 비특이적인 정서장애가 생겨 진단과 치료가 빠르게 되지 않은 경우이다. 비록 뇌졸중보다 다른 신경학적인 질환이 이 증상을 더 흔하게 유발할 수 있어도 전체적으로는

뇌졸중이 다른 질환보다 훨씬 많이 나타나기 때문에 임상적으로는 뇌졸중, 특히 다발성 뇌졸중 환자에서 이 증상을 더 자주 볼 수가 있다. 따라서 임상가가 과거에 정신질환 병력이 없고 미묘할지라도 신경학적 이상을 동반하는 고령의 노인 환자가 정서 조절장애가 심하다면 이 증상의 신경학적 원인을 찾아서 기저질환의 치료와 함께 이 증상에 대한 약물 치료를 시도해야 한다. 그리고 마지막으로 이 증상은 약물 치료만으로 완전히 좋아지기는 힘들기 때문에 이와 연관된 인지행동 치료가 같이 시행되어야 하며, 이 증상에 대해서 환자와 환자 간병 가족의 교육이 반드시 필요하다.

References

1. Pioro EP. Current concepts in the pharmacotherapy of pseudobulbar affect. *Drugs* 2011;71(9):1193–207.
2. Patalanian E, Casselman J. Dextromethorphan/quinidine for the treatment of pseudobulbar affect. *Consult Pharm* 2014;29(4):264–9.

1년 전부터 시작된 배회를 주소로 내원한 76세 남성

증례

76세 남성이 5년 전부터 서서히 진행되는 기억력 장애와 1년 전부터 발생한 지속적인 배회를 주소로 내원하였다. 본인이 했던 행동들을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 1년 전부터 환자는 혼자서 돌아다니는 행동, 초조 불안, 불면 등의 증상이 있었다. 환자는 1년 전부터 오후 3~4시 경부터 치매 증상이 더 심해지고, 집을 나가려는 증상이 있었으며, 일단 나가면 집을 찾지 못하였다. 환자가 안절부절 못하는 증상은 저녁 이후까지 지속되며 밤에도 배회하고 수면도 잘 취하지 못하거나 쪽잠을 자는 등의 증상이 보였다. 하지만 환자가 거주하는 곳은 농촌의 작은 마을로 큰 위험성이 있는 구조물이 없고 주민들이 모두 환자와 친밀한 사람이어서 길을 잃어도 큰 문제 없이 집을 다시 찾았다. 때로는 경찰의 도움으로 수차례 보호되기도 하였다. 문제는 최근 마을에 도로 공사가 있어서 이와 관련된 새로운 장애물이 많이 생겼는데 배회하던 환자가 넘어져 수차례 외상이 있었다.

기저질환으로 고혈압이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않았다. 신경학적 검사 상 의식은 명료하였으며, 뇌신경, 운동 기능 및 감각 기능 검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상 소견은 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고,

소뇌 기능 검사와 보행도 정상이었다.

신경심리 검사 시 숫자 따라 말하기는 2자리까지 가능하였고, 거꾸로 말하기는 2자리까지 가능하였다. 실행증 검사, 좌우 지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽 기능장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다. 시공간 능력은 유지되어 있었다.

한국판 간이정신상태 검사(Korean-Mini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2)는 30점 만점에 19점으로 장소보다도 시간에 대한 지남력이 떨어져 있고, 주의집중력이 떨어져 있으며, 기억등록과 회상에 문제가 있었다. 임상치매척도(clinical dementia rating, CDR)는 1점이었다. 일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선

기능 검사 상 특이 소견은 없었고, apoE 검사에서 e3/e4 관찰되었다. 뇌자기공명영상에서는 양측의 전반적인 뇌위축이 관찰되었다(그림 1).

신경심리 검사 및 뇌영상 검사를 통해서 알츠하이머병으로 진단하였다.

고찰

알츠하이머병을 비롯한 치매 환자에서 배회(wandering)는 치매 환자나 보호자를 가장 힘들게 하는 신경행동증상 중 하나이다. 치매 환자에서 왜 배회가 생기는지는 아직도 잘 알려지지 않았으며, 이 원인에 대한 연구는 생물학적, 심리환경학적 가설이 있다. 먼저 생물학적 가설은 공간 기

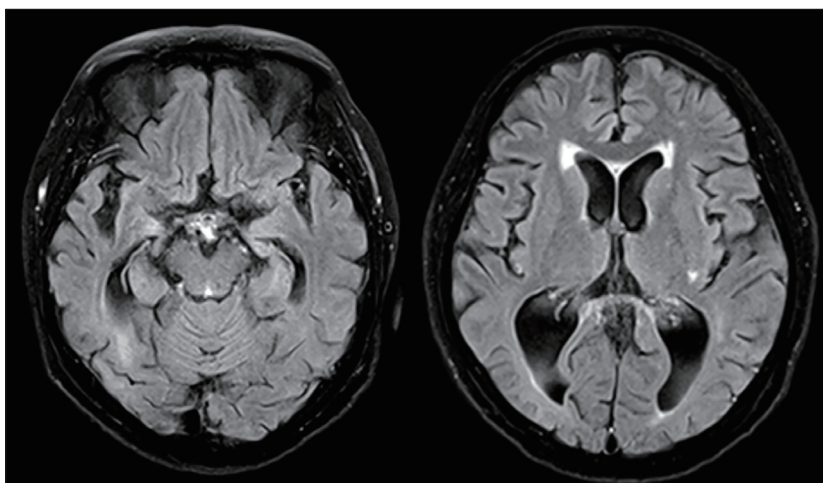


그림 1. Magnetic resonance imaging of the patient
Axial FLAIR sequences of the patient represent diffuse brain atrophy

억, 시공간 기능, 그리고 실행 기능과 같은 뇌의 특정 부위 손상과 배회가 관련 있다고 생각한다. Tetewsky는 시공간 기능 손상이 배회를 일으킨다고 주장하였고, McShane은 공간 기억의 손상이 배회와 연관이 있다고 보고하였다. 또 다른 연구에서는 알츠하이머병 환자에서 광학적 흐름 지각(optic flow perception)과 그 해석의 장애가 목적지까지 잘 못 찾아가는 행동장애의 기본이라고 보고하였다. 반면 Benton은 생각을 실행으로 실천하는 데의 문제, 즉 의사결정, 계획, 모니터링의 손상이 배회와 연관된다고 주장하였다.

배회는 네 가지 지리적 형태를 보인다.

첫 번째는 출발점과 종점이 같은 폐회로

(closed loop) 형태를 보이는 lapping, 두 번째는 두 지점을 왕복하는 pacing, 세 번째로는 계속 방향이 변하는 random이며, 마지막으로 주저함 없이 일정 방향으로 목적지까지 가는 direct 네 가지 형태가 있다. 이 배회 형태 중에 lapping이 가장 비효율적인 보행 형태이며, 치매의 정도와 연관성이 있다고 보고되었다. 배회는 실종, 체중 감소, 불면, 외상 등을 일으키며 결국 집에서 기관으로 이송되게 하는 환자나 환자 보호자, 치료자 모두에게 힘든 증상이다. 배회 환자는 그렇지 않은 환자에 비하여 낙상 위험성이 3배, 골절 위험성도 2배 높은 것으로 보고되고 있다. 기관에서는 배회하는 환자는 다른 환자와 문제를 일으킬 수 있으며, 식

사나 배뇨배변과 같은 일상생활에 지장을 주기도 한다. 결과적으로 물리적이거나 화학적인 강박이 배회를 보이는 환자에게 더 많이 시행되기도 한다. 마지막으로 배회는 환자의 사망에도 중요한 요인이 된다. 아직도 배회는 현실과 학문적인 이론 사이에는 많은 간극이 존재하여 실질적인 치료나 간병에 많은 어려움을 겪고 있다. 아직 배회의 치료에 관하여 신뢰성 있는 무작위 조절 연구가 거의 없으므로 먼저 권유할 수 있는 효과적이라고 할 만한 약물, 비약물 치료지침이 존재하지 않는다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 배회에 대한 더 많은 연구가 필요할 것이다.

물건을 자꾸 쌓아두는 73세 여성

증례

73세 여성이 2년 전부터 서서히 발생한 기억력 저하 및 우울감으로 내원하였다.

환자는 대화 시에 금방 내용을 이해하지 못해 같은 질문을 반복하고, 당일 병원 일정도 수차례 알려주고, 달력에 메모도 있으나 일정을 스스로 챙기지 못하여 도움이 필요하였다. 최근 한두 달 전의 중요한 일들로, 3주 전에 있었던 환자의 생일에 ‘본인도 자기 생일인지 모르는데 자식들이 어떻게 아느냐며 생일날 아무 것도 하지 않았다’고 보고하였으나, 실제 딸들이 방문하여 음식을 차려드렸으며, 이를 전혀 기억하지 못하였다. 또한 최근 시사로는 작년과 달리 현직 대통령 이름을 대지 못하고 선택지를 주어도 전직 대통령 이름을 언급하였다. 올해 2월 신분증, 통장을 분실하여 재발급 과정을 설명해 주었으나 이에 대해 잘 이해하지 못하여 어려움이 있었다고 하였다.

평소 복지관에 전철을 타고 가서 여러 가지 취미활동에 참여했으나 작년에 한 차례 정거장을 혼동하는 일이 생겼고, 이후로 혼자 대중교통을 이용하는 것에 자신 없어 하며 혼자서 집 밖에도 잘 나가지 않으려 하였다. 올해 초에는 혼자 집 근처에 외출했다가 순간적으로 동네 길에서도 집이 어딘지 헛갈렸던 적도 있다고 보고하였다.

혼자 거주하면서 직접 집안 살림을 하며

금전 관리도 했던 분이나 작년부터는 식사를 잘 챙겨먹지 않고 집안 정돈도 잘 되지 않으며 살림에 의욕이 저하되었다고 보고하였다. 아직 가스렌지로 음식을 데우는 정도는 가능하나, 상한 음식을 잘 구별하지 못하고 냉장고에 음식이 있어도 잘 먹지 않는다고 하였다. 세탁물도 제대로 내놓지 않고 세탁기를 돌릴 생각도 하지 않으며, 집안에 물건을 가득 쌓아두어 걸터다닐 곳이 없다고 보고하였다. 가방이나 지갑을 쌓아둔 짐 사이에 숨겨두고 못찾으면 자녀들이 훔쳐갔다고 생각을 하고 화를 심하게 내어 최근에는 자녀들이 집 방문도 제대로 하기 힘들다고 하였다. 물건이 자꾸 없어진다고 하여 집안에 CCTV를 설치하였는데, 우연히 보게 된 CCTV 녹화영상

에서 자녀들이 선물한 케익을 옷더미 사이에 숨겨두었다가 밤에 일어나 찾아 헤매는 모습을 보여 보호자가 깜짝 놀랐다고 하였다(그림 1).

환자는 오른손잡이이며, 고졸로 50대 후반까지 슈퍼마켓, 식당운영을 했고, 비슷한 시기에 아파트 등 부동산 임대업도 병행하였다고 한다. 현재 고혈압, 고지혈증으로 약물 복용 중이며, 가족력 상 오빠가 알츠하이머병으로 투병 중이었다.

혈액 검사에서 ApoE 유전자 검사는 ε3/ε4형 이었고, vitamin B12, folic acid, homocysteine, 갑상선 기능 검사 상 모두 정상 소견이었다.

SNSB 검사에서 KMMSE 20점, CDR 1(SOB 6.0), GDS 5점, K-IADL 0.6점이었으며, 모든 인지 영역이 최하 수준으로



그림 1. 새벽 1시 29분경, 자다 일어나서 물건이 가득 쌓여진 방 안에서 케익을 찾고 있는 모습

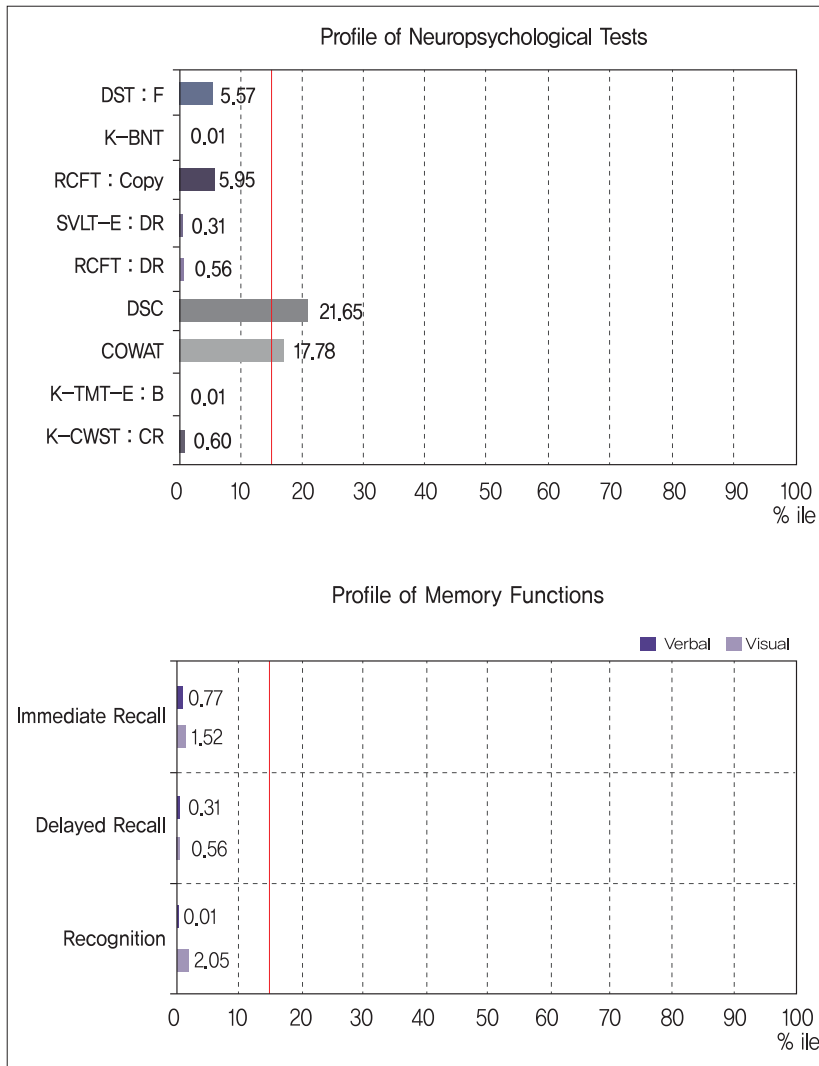


그림 2. Seoul Neuropsychological Screening Battery(SNSB) 결과 : 전두엽 기능 검사의 일부인 digit symbol coding(DSC), controlled oral word association test(COWAT)에서만 정상 범위를 보이고, 그 외 모든 인지 기능 검사에서 비정상 소견을 보임

저하되어 있었다(그림 2). 또한, NPI 22점으로 망상, 비협조적 행동, 우울, 불안, 무감동/무관심, 탈억제, 화를 잘냄, 식욕 변화 등 이상 행동증상을 다양하게 동반하고 있었다.

뇌영상 검사에서는 양측 해마에서 medial temporal lobe atrophy(MTA) score 4점/4점으로 위축이 관찰되었다(그림 3).

이상의 검사 결과를 토대로 알츠하이머병으로 진단하고 donepezil을 시작하였으며, 동반된 신경행동증상 중 수집행동(hoarding behavior) 및 무감동/무관심(apaty), 불안(anxiety)증상의 완화를 위해 sertraline을 투약하였다. 2달 후 재내원했을 때 환자는 안정을 많이 찾았다.

고찰

신경행동증상(neurobehavioral symptom)은 크게 정신병증상(psychotic symptoms)과 행동증상(behavioral symptoms)으로 분류되는데, 수집행동(hoarding behavior)은 행동증상 중 환경의존증후군(environmental dependency syndrome)의 하나로 분류된다. 환경의존증후군은 사회환경이나 신체환경 자극(social and physical environmental stimulus)에 지나친 반응을 보이면서 이를 스스로 통제하지 못하는 경우를 말하

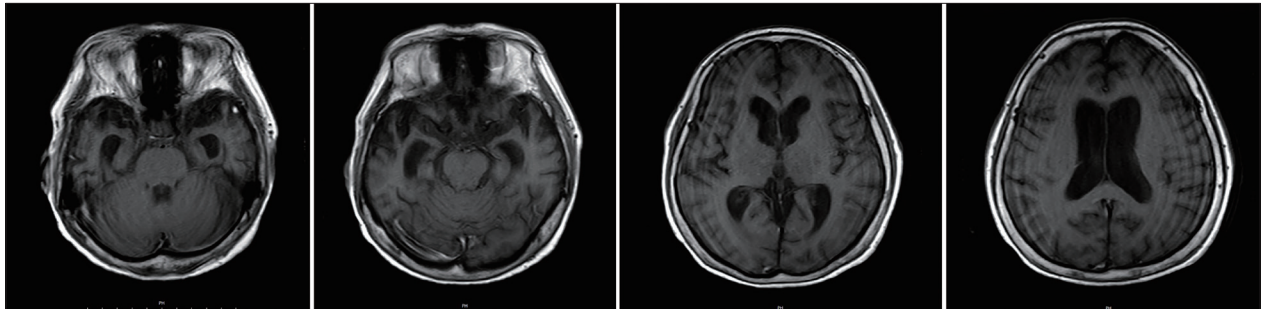


그림 3. 뇌영상 검사 결과 : 양측 해마의 위축이 관찰됨

며, 전두엽장애로 인한 수행장애증후군(dysexecutive syndrome)의 일종으로 추정된다. 수집행동(hoarding behavior)은 가치가 낮거나 불필요한 물건을 과도하게 축적하고 버리지 못하는 행동을 의미하는데, 주로 전두엽(frontal lobe), 전대상피질(anterior cingulate gyrus)과 연관이 되어 있는 것으로 알려져 있다. 원인 질환으로는 전두측두엽치매, 혈관치매, 진행핵상마비, 외상뇌손상 등이 있다.

본 환자의 경우 알츠하이머치매에서 동반된 수집행동으로, 이러한 행동은 환자의 생활 공간을 혼란스럽게 만들고 일상 활동에 방해가 되어 보호자의 부담도 커질 수밖에 없다. 치료로는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs), venlafaxine과 같은 비정형 항우울제, 벤조디아제핀(단기간 사용), 부스피론 등의 항불안제, 항정신병약을 단기간 사용해 볼 수 있으며, 환자의 증상과 반응에 따라 약물을 조절해야 한다.

씨 유 어게인

저자 : 김지윤 출판사 : 클레이하우스



따뜻한 밥으로 '노 프라블럼'을 외치는 고짜 할머니!
각자도생의 우리를 위로할 진짜 어른이 나타났다.
“내 밥 먹으면 만사가 노 프라블럼이여!”

『연남동 빙글빙글 빨래방』 김지윤의 '혜화동 이야기'

세상에서 가장 맛있고 따뜻한 오지랖이 시작된다! '만나 도시락'을 중심으로 사람과 사람이 모여, 서로의 아픔과 상처를 돌보면서 서로의 삶을 회복하는 힐링 드라마.

우리말로 '맛나다'와 '만나다'의 발음이 같다는 사실을 알고 있습니까? 혜화동의 작은 도시락 가게 '만나 도시락'에는 그냥 노인이 아니라 어른으로 불리고 싶은, 뉴요커를 꿈꾸며 매일 영어 공부를 하는 고짜 할머니 정금남 여사가 매일 새벽부터 늦은 밤까지 따뜻한 밥과 반찬을 준비해 손님들에게 내어준다. “음식으로 못 고치는 병은 약으로도 고칠 수 없다”라는 말처럼, 정성 가득한 맛있는 음식과 살짝 귀찮으면서도 마음 한편이 따뜻해지는 주인 할머니의 오지랖을 듣다 보면, 어느새 '밥심'의 위력을 깨닫게 된다.

피보다 진한 엄마와 딸의 사랑, 미혼모와 노숙자가 상처를 딛고 자기 삶을 회복하는 이야기, '손흥민'이라는 이름과 다르게 자신감 없는 중 2 소년과 아이를 갖지 못해 힘들어하는 30대 간호사의 성별과 세대를 초월한 우정, 잊고 살았던 꿈을 향해 다시 나아가는 정혜인을 닮은 달걀 장수 이야기 등 소설 속 혜화동 사람들의 삶은 우리에게 평범한 일상과 닮아 있다. 그들의 이야기를 통해 독자들은 각박한 일상에 위로를 얻고, 주변 사람들의 온기를 돌아보며, 마침내 자신의 삶을 사랑할 용기를 얻을 것이다.